

Wykres *nastroju*

Codzienny zapis nastroju, snu i energii. Jedno z najważniejszych narzędzi w chorobie afektywnej dwubiegunowej — pokazuje wzorce wcześniej niż Ty sam/a je zauważysz.

CZAS: 2 min dziennie Codziennie, najlepiej wieczorem

ŹRÓDŁO: Basco & Rush (2005); Goodwin & Jamison (2007)

JAK UŻYWAĆ

Każdego wieczora zapisz **trzy liczby**: nastrój od -5 (głęboka depresja) przez 0 (równowaga) do +5 (silna mania); długość snu w godzinach; energię od 0 do 10. Dodaj jednoznakowe oznaczenia:  jeśli wzięłeś/-aś leki,  jeśli był alkohol,  jeśli była stresująca sytuacja. Nie staraj się oceniać „dobrze/źle” — opisz, co było.

DLACZEGO TO DZIAŁA

ChAD ma charakter **epizodyczny i cykliczny**. Twoja samoocena „jak się czuję” jest zniekształcona w obu kierunkach — w hipomanii czujesz się świetnie (a tracisz wgląd), w depresji wszystko wydaje się beznadziejne (a to mija). Wykres pokazuje **trend** niezależny od chwilowego nastroju. Lekarz i terapeuta widzą wzorce z 2-4 tygodni szybciej i precyzyjniej niż z wywiadu — to bezpośrednio przekłada się na trafniejsze decyzje o leczeniu.

DZIŚ Zaznacz, jak czujesz się w **tej chwili** — bez analizy, intuicyjnie.

**Nastrój
dziś**

depresja (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

mania

01 Jak ocenić nastrój — skala od -5 do +5

Skala dwubiegunowa. **0** to stan, który Ty znasz jako „swoj normalny” — nie idealny, tylko stabilny. Wartości ujemne to depresja, dodatnie — wzrost energii aż do manii. Większość dni będzie w przedziale -2 do +2.

BIEG DEPRESYJNY

- 5 · krytyczna depresja — myśli samobójcze, nie wstaję z łóżka
- 3 · ciężka depresja — codzienne funkcjonowanie z trudem
- 2 · łagodna depresja — wszystko męczy, ale działam
- 1 · obniżenie — gorszy dzień, smutek bez powodu

BIEG MANIAKALNY

- +5 · mania pełnoobjawowa — psychoza, ryzykowne decyzje
- +3 · hipomania nasilona — mało snu, dużo pomysłów, gadanie
- +2 · hipomania łagodna — produktywność wzrasta, energia
- +1 · wzrost — lepszy dzień, więcej chęci do działania

0 · EUTYMIA (RÓWNOWAGA)

Stan, do którego dążysz — nie euforia, lecz stabilność. Sen 7-9 h, energia wystarczająca na zaplanowane zadania, emocje proporcjonalne do sytuacji. To jest cel leczenia.

02 Co dokładnie notujesz

NASTRÓJ

-5 ... 0 ... +5

Średnia z dnia. Jeśli rano i wieczorem różnica większa niż 2 punkty — zapisz obie wartości.

SEN

godziny + pora

Ile godzin spałeś/-am ostatniej nocy. Pora zaśnięcia. **Sen poniżej 6 h = sygnał ostrzegawczy.**

ENERGIA

0 ... 10

Niezależnie od nastroju. Czasem nastrój 0 a energia 2 (apatia) — to **oddzielne wymiary**.

03 Wykres — 2 tygodnie

Wypełniaj codziennie wieczorem (przed snem). Po 14 dniach pokaż lekarzowi/terapeucie — wzorce zobaczycie razem.

DZ.	NASTRÓJ -5 ... +5	SEN h	ENERGIA 0 ... 10	OZNACZENIA   	NOTATKA co zwróciło uwagę
Pn					
Wt					
Śr					
Cz					
Pt					
Sb					
Nd					
Pn					
Wt					
Śr					
Cz					
Pt					
Sb					
Nd					

04 Najczęstsze błędy

BŁĄD 1 · TYLKO GDY ŻŁE

Notujesz wyłącznie w gorszych dniach. Wtedy wykres pokazuje samą depresję — brak punktu odniesienia. Notuj *codziennie*, nawet gdy „normalnie”.

BŁĄD 2 · HIPOMANIA = NORMA

Wpisujesz +2/+3 jako 0. W hipomanii czujesz się dobrze i tracisz wgląd. Zasada: jeśli śpisz mniej niż zwykle a masz *więcej* energii — to nie norma.

BŁĄD 3 · ANALIZA ZAMIAST ZAPISU

Tracisz 20 minut na ocenę, czy to 0 czy -1. Cel: 2 minuty. Intuicyjnie, szybko. Dokładność nie liczy się tak bardzo jak *regularność*.

BŁĄD 4 · KRÓTKI OKRES

Po tygodniu uznajesz, że już wiesz. Cykl ChAD trwa tygodnie, czasem miesiące. *Minimum 4-8 tygodni*, by zobaczyć rytm.

Klucz: wykres nastroju to *jedyne* narzędzie, które koryguje zaburzenia samooceny w obu fazach. Pacjenci prowadzący wykres przez 6 miesięcy mają o **40% niższe ryzyko nawrotu** wymagającego hospitalizacji (Bauer i wsp. 2006). Lekarz potrzebuje tych danych do precyzyjnej regulacji farmakoterapii — wywiad „jak ostatnio?” nie wystarczy.